

# Venere — Costruire la lista dei target (starter)

Strumento operativo di origination. Riservato.

## Premessa: come si costruisce DAVVERO la lista

**Non con Google.** Le cliniche famose che compaiono online sono o troppo grandi/branded o non vendono — non sono il target. Il target è la **coda lunga di studi mid-small** (€0,8-2,5M) che si trova con: 1. **Database finanziari** (AIDA / Cerved / Bureau van Dijk) → screening oggettivo dell'universo per bilanci. 2. **Registri autorizzazioni sanitarie regionali** → l'universo delle strutture ambulatoriali per provincia. 3. **Network clinico di Marcello + fornitori** → intel qualitativa e **vie calde** (chi possiamo raggiungere con un'intro). 4. **Associazioni e congressi** → i medici di riferimento per città.

## Il profilo target (dal deck)

- Ricavi **0,8-2,5M**, EBITDA **20%+** (verificabile/normalizzabile)
- Bacino **100k+ abitanti**; cluster prioritari (sotto)
- Base pazienti **1.500+**, quota **iniettabili/ripetibili** prevalente
- **2+ medici** o convertibile a multi-provider entro 12 mesi
- Titolare disponibile a **permanenza 24-36 mesi + rollover**
- Autorizzazioni in regola, sede ampliabile

## Scorecard di screening (griglia di punteggio)

Punteggio 1-5 per criterio × peso → totale pesato → priorità **A / B / C**.

| Criterio                                                    | Peso | Punteggio (1-5) | Note                                   |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------|
| Dimensione (ricavi 0,8-2,5M) ed EBITDA 20%+                 | 20%  |                 |                                        |
| Quota iniettabili / trattamenti ricorrenti                  | 15%  |                 | recurring-amenable                     |
| Bacino e location (100k+, reddito)                          | 10%  |                 |                                        |
| Multi-provider o convertibilità                             | 10%  |                 | 2+ medici o headroom                   |
| Qualità bilanci / verificabilità (POS, fornitori)           | 15%  |                 | anti-nero                              |
| Motivazione e apertura del titolare                         | 15%  |                 | pensione / crescita / stanchezza admin |
| Fit culturale e reputazione clinica                         | 5%   |                 | zero baggage                           |
| <b>Via calda disponibile</b> (network Marcello / fornitore) | 10%  |                 | quanto è raggiungibile caldo           |
| <b>Totale pesato</b>                                        | 100% |                 | → A (≥4), B (3-4), C (<3)              |

---

## Dove prendere i dati (fonti concrete)

- **AIDA / Cerved:** filtra per **codice ATECO** (es. 86.22 *studi medici specialistici*, 86.90 *altri servizi sanitari*) + **regione/provincia** + **ricavi 0,8-2,5M** → estrai l'universo con bilanci. Screening finanziario oggettivo.
- **Registri regionali delle strutture sanitarie autorizzate** (ambulatori/poliambulatori) → l'universo per provincia.
- **Fornitori di iniettabili/device** (rep AbbVie/Allergan, Galderma, Merz; laser) → **volumi reali** + intro calde.
- **Associazioni** (AITEB, SIME, AICPE, SMPeC) e **congressi** (liste relatori/espositori) → medici di riferimento per città.
- **Network di Marcello** → intel qualitativa (chi vende, chi è credibile, chi è vicino alla pensione) + le vie calde.

---

## Il funnel (dall'universo alla shortlist)

1. **Universo** (registri + AIDA: centinaia per cluster)
2. → **Screen finanziario** (ricavi 0,8-2,5M, margine) → decine
3. → **Screen di fit** (iniettabili, multi-provider/convertibile, bacino) → ~15-25
4. → **Screen "via calda"** (chi possiamo raggiungere con intro) → ~10
5. → **Shortlist prioritizzata A/B/C** con la scorecard → **5-8 target A** per il primo cluster

---

## Cluster map (priorità)

Regola: **un solo cluster per partire** (densità = leva operativa).

- **Nord-Ovest — priorità 1:** Milano + hinterland, Torino, Brescia, Bergamo. Densità, reddito, bacino.
- **Nord-Est — priorità 1:** Verona, Padova, Venezia, Bologna. (*Verona lega alla pratica esistente di Marcello → vie calde naturali.*)
- **Roma — priorità 2:** grande bacino ma dinamiche/frammentazione diverse → secondo cluster.

**Suggerimento:** parti da **Milano** (dove metti anche il flagship-pilota) o **Verona-Padova** (dove Marcello ha radici e intro immediate).

---

## La punta visibile (contesto, NON target vettati)

Cliniche pubblicamente note a Milano — utili come **benchmark del segmento branded/alto**, per lo più **troppo grandi o non venditrici**, quindi *non* il target tipico: *theClinic*, *IDE (Istituto Dermatologico Europeo)*, *Equipe*, *Meldes*, *Clinica Luce*, *Sotherga* (e gruppi ospedalieri come MultiMedica, che NON sono target). Servono a capire il posizionamento premium; **non contattarle a freddo**. I target reali sono i **mid-small non-branded** che escono dallo screening AIDA + network.

---

## Prossimi passi operativi

1. **Estrai da AIDA** l'universo del primo cluster (ATECO + regione + ricavi 0,8-2,5M).
2. **Con Marcello**, sovrapponi il suo network ai risultati → chi possiamo raggiungere caldo.
3. **Prioritizza con la scorecard** → shortlist **A (5-8 target)**.
4. **Attiva le vie calde** (Marcello + fornitori) → primi **incontri informali tra pari** (vedi playbook di approccio nel Piano).

*Nota: questo è il metodo per costruire la lista con dati reali e verificabili. Non contiene numeri di bilancio o segnali di "disponibilità a vendere" su cliniche specifiche: quelli vanno raccolti da AIDA/Cerved e dal network, non stimati a tavolino.*